

03 - 3-semiologie oesophage sono maker

Elle est très obèse. Voici l'aérophile Henri Lagarde. Remarquez que plus le volume, la peau essaie d'exceller à ce niveau-là, des complications dermatologiques.

Et vous voyez que l'obésité, la dame est très obèse, ce qui fait les difficultés dans la préparation. Donc on va voir la sébiologie. Alors la difficulté à déglutir, ça s'appelle une dysphagie.

La dysphagie. Le reflux du contenu gastrique dans les oesophages s'appelle le reflux gastro-oesophagien. Il faut rappeler que le reflux gastro-oesophagien est une pathologie qui est très fréquente.

Et elle est sous-estimée chez la population normale. Souvent les gens, même s'ils ont un revenu, ils le sous-estiment et ils consultent peu. C'est la raison pour laquelle il reste longtemps à l'attente jusqu'à le moment où il va y avoir des complications secondaires à ce reflux.

C'est-à-dire la remontée du contenu gastrique et acide qui va altérer la muqueuse oesophagienne. Je vous rappelle que la lumière oesophagienne n'est pas normale maintenant. Elle est virtuelle.

Elle est fermée. L'oesophage est fermé. Ce n'est pas comme l'espoir.

Alors que l'espoir, il y a une lumière où il y a des aliments qui peuvent rester pendant des minutes voire des heures. Et il y a aussi de l'air. Si on fait une radio sans préparation, on peut voir le niveau de l'air qui existe au niveau de l'espoir.

Alors que l'oesophage, normalement, dès que le patient ou l'individu, on ne va pas l'appeler patient, dès que la personne ne mange pas, normalement, la lumière, elle est virtuelle. Elle est fermée. L'interrogatoire, l'anamnèse avec le patient, il est très important.

Rappelez-vous que l'oesophage, c'est un organe qui est profond. Il est inaccessible à l'examen. Donc, à part l'interrogatoire et l'anamnèse, vous ne pouvez pas l'inspecter.

Vous n'allez pas pouvoir le battre, le percuter. C'est un organe très profond. L'oesophage, il est profond dans le thorax.

Je vous rappelle qu'il mesure 25 centimètres de long. Rappelez-vous de l'anatomie, 25 centimètres de long. Il commence au niveau de la bouche, l'oesophage est ce qu'on appelle la bouche du quinié.

Au niveau du défilé cervico-thoracique, il y a un trajet cervical qui est court, qui ne dépasse pas les 5 à 8 centimètres. Puis, il y a un trajet thoracique. Et puis, il y a un trajet abdominal qui fait 2 à 3 centimètres.

Donc, pour l'explorer, les amendes complémentaires idéales à demander, c'est la fibroscopie, c'est l'endoscopie que pratiquent les médecins gastro-opérologues. Grâce à la fibroscopie, on introduit un oxyde souple dans la lumière oesophagique. C'est des amendes complémentaires.

On peut le pratiquer dans un cabinet privé dans le cabinet d'un médecin gastro-opérologue ou on peut le pratiquer dans une structure hospitalière ou en clinique. Si le malade tolère mal l'examen complémentaire, s'il a besoin de sédation ou d'anesthésie générale, il y a des patients qui sont stressés, qui ont une phobie, ils ne tolèrent pas, et parfois, il s'agit qu'il arrache l'endoscope. Et comme vous le savez, le fibroscope, c'est précieux et c'est un matériel qui est fragile.

Dans ces cas-là, on peut proposer aux patients de faire cet examen complémentaire sous sédation ou sous anesthésie générale. Cette endoscopie va introduire un tube qui est souple et une caméra, et on va voir, on va explorer. Depuis l'orifice cervical, on va descendre, voir la lumière et la muqueuse esophagienne.

On va pouvoir la voir. On va voir, d'une part, est-ce qu'il y a des aliments. Normalement, ils ne doivent pas exister lors de l'examen.

S'il y a, par exemple, des aliments, c'est qu'il y a une séance sous-jacente. Donc, s'il y a des résidus alimentaires, on va explorer la raison de cette dysphagie, de ce trouble de la déglutition. Et on peut aussi voir ce qu'est constitué le reflux de l'astérosophage, c'est-à-dire quand on trouve de la bile.

Normalement, lors de l'examen de la fibroscopie digestive, lorsqu'on explore l'esophage, il n'y a pas de bile dans la lumière esophagienne. S'il y a de la bile, ça veut dire que le malade présente une défaillance du sphincter esophagien inférieur. Normalement, il est tonique.

C'est un sphincter qui permet l'étanchéité de cette barre esophage et il fait offrir au reflux gastro-esophagien. Si c'est un risque, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas la fibroscopie. Par exemple, si vous allez choisir comme spécialité la gastro, on ne va pas vous donner dès le premier jour de pratiquer une fibroscopie.

Vous allez être assisté. La première des choses, c'est que vous allez le voir. Il faut être très souple dans le maniement des instruments.

Il ne faut pas être brutal. Il ne faut pas être un peu émérvé. Donc, il faut pratiquer la fibroscopie avec toute la finesse, avec la souplesse.

Il ne faut pas brutaliser. Surtout lorsque l'organe est malade. Il y a des pathologies.

Je vous donne l'exemple. Par exemple, les ingestions de produits caustiques. Il y a des patients qui font des tentatives de suicide.

Ils boivent des produits caustiques. L'osopage est très fragile. Rien qu'avec l'introduction de

l'endoscope, on peut perforer l'œsophage et se retrouver dans le thorax.

Donc, il faut faire la fibroscopie avec douceur. Il faut prendre ses précautions. Il faut que le malade soit relâché pour voir et éviter les perforations par endoscope.

Ils existent. Moi, en tant que chirurgien, j'ai opéré pas mal de patients où il y a eu des accidents. Des accidents de perforations par un fibroscope de digestive haute ou bien par coloscopie.

Ça dépend de l'examen complémentaire. Si c'est une fibroscopie, on peut se retrouver facilement dans le thorax. Ça peut entraîner une diastémie.

Si, par exemple, la perforation se produit par un coloscopie, ça peut entraîner une péripéritonite. Donc, ça peut entraîner une péripéritonite. Mais, dans tous les cas, un médecin qui n'a pas eu ce genre d'accident, c'est un médecin qui ne pratique pas.

Celui qui n'opère pas, qui ne pratique pas les examens complémentaires et qui n'a pas de complications, c'est un médecin qui n'a jamais pratiqué. Si jamais vous rencontrez un médecin qui vous dit « Ah, moi je suis parfait, je n'ai jamais eu de complications, de perforations. » C'est tout simplement qu'il n'a jamais fait de fibroscopie.

Vous voyez ? Donc, les perforations existent. Le pourcentage est réduit, moins de 1%. Mais, quand ça existe, le médecin doit assumer.

C'est-à-dire qu'il doit contacter le chirurgien pour opérer le patient, pour fermer et sécuriser la perforation. C'est ça, la communication. Donc, il faut communiquer, il faut admettre qu'on a commis une complication et il faut la réparer.

Mais les perforations existent. Donc, là, il s'agit que vous, en tant que médecin, vous allez demander au patient, sur un certain nombre, la date de début des troubles. Ça peut coïncider avec une ingestion caustique, mais les causes les plus fréquemment rencontrées en pathologie, ce sont les tumeurs, les cancers de l'œsophage.

Maintenant, on va survoler rapidement les différentes étiologies des dysphagies. Vous allez les connaître. Et puis, l'année prochaine, vous allez voir en pathologie, on va voir ensemble le cours des cancers de l'œsophage.

Et vous allez étudier aussi le revenu en pathologie, en gastro-entérologie. Vous allez voir aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de connaître la sémiologie, la dysphagie. Cette dysphagie, il faut admettre qu'elle est de haut en bas.

Elle est soit intermittente au spasmodique, c'est-à-dire que le patient la rapporte de temps à autre, ou bien elle est permanente. Chaque fois qu'il mange, il sent une difficulté que les aliments descendent dans l'estomac. Spasmodique, ça veut dire qu'elle peut survenir suite à une pathologie que vous allez voir.

C'est surtout lorsque le sphincter ne se relâche pas. C'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Et vous avez vu que le sphincter inférieur de l'œsophage, vous l'avez étudié en anatomie, il faut se rappeler que c'est un sphincter qui ne correspond pas à une réalité anatomique.

C'est pas comme le sphincter du baréton, c'est-à-dire des fibres circulaires. C'est vrai, les fibres circulaires existent, mais le sphincter inférieur de l'œsophage, il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il comprend le sphincter anatomique, l'épaississement des fibres circulaires, il comprend la variante de la pression positive de l'abdomen et négative dans le thorax, il comprend les piliers du muscle diaphragme, ces piliers qui cravatent le bas-œsophage.

Ils ont un rôle dans l'étanchéité du sphincter inférieur de l'œsophage. Le sphincter inférieur de l'œsophage, il est beaucoup plus complexe et il comprend beaucoup de choses. La dysphagie peut être d'abord au solide puis au liquide puis au liquide, alors que, par exemple, dans le méga-œsophage, dans le méga-œsophage, c'est une dysphagie particulière.

Elle est au liquide, d'abord au liquide. Pourquoi ? Parce que c'est les muscles qui ne se relâchent pas. Le muscle ne se relâche pas et le sphincter, il est hyperphonique.

D'accord ? Donc, elle peut être popale. Paradoxal, comme on vient de le dire dans le méga-œsophage, on peut avoir des régurgitations, c'est-à-dire la remontée des aliments dans la bouche sans effort de vomissement. Il faut faire la différence entre régurgitation et vomissement.

Régurgitation, c'est le rejet des aliments alors qu'ils n'ont pas traversé le sphincter du bas-œsophage. Alors que les vomissements, c'est le rejet d'aliments qui ont dépassé le sphincter inférieur de l'œsophage à partir de l'estomac. Donc, c'est ça la différence entre vomissement et régurgitation.

Alors, dans le syndrome œsophagien, il y a ce qu'on appelle l'hypersialorrhée. Retenez bien que l'hypersialorrhée, ce n'est pas une hypersialorrhée qui est vraie. En fait, inconsciemment, maintenant, vous déglutissez votre salive.

Il y a un débit inclus, continu pendant les 24 heures, de la salive qui est de 1 litre et demi. Le monsieur qui a une tumeur du bas-œsophage, c'est d'abord ça qu'il ne peut pas déglutir sa salive. Donc, les 1 litre et demi, ils vont stagner.

Il va les rejeter sous forme de régurgitation. Donc, ce n'est pas une hypersialorrhée. C'est une fausse appellation.

C'est tout simplement le débit de la salive, mais il n'en profite pas parce que notre salive, on la récupère. Rappelez-vous du cycle antéro-hépatique dont on a parlé la dernière fois. La masse liquidienne, elle fait partie des 6 litres.

1 litre et demi, elle fait partie des 6 litres. Donc, normalement, et physiologiquement, je récupère

maintenant la salive que je déglutis, je la récupère en la réabsorbant dans mon gestionnaire. D'accord ? Je la récupère sous forme d'eau et d'électrolyte, sodium, potassium, anticorps, tous les contenus et les enzymes, l'amylase, tous les enzymes qui existent dans ma salive, je dois la récupérer.

Donc, cette hypersialorrhée, il faut l'apprendre entre guillemets, ce n'est pas un terme qui est vrai, mais c'est le débit normal de la salive qui n'est pas récupérée et réabsorbée. Donc, hypersialorrhée, brûlure rétro-sternale et améglissement. Le monsieur qui a une dysphagie, le malade qui a une dysphagie, à la longue, après une semaine, deux semaines, il va perdre du poids, il va subir une dénutrition et un améglissement.

Quand on a un obstacle organique, tumeur, séance inflammatoire, etc., normalement, la dysphagie au début, c'est une dysphagie au solide, on est d'accord, c'est pas vraiment s'il prend un petit pain le matin, ou un petit peu de pain, il va sentir la dénutrition, la gêne à la dénutrition. Alors que le malade qui a un méga-osophage, une hypertonie dans le secteur inférieur de l'osophage, il a une dysphagie paradoxale, d'abord au liquide. Il aura beaucoup plus une hypersialorrhée qu'une dysphagie.

Donc les liquides auront du mal à franchir le... Et si on prend par exemple le malade qui a le méga-osophage, s'il prend du pain, peut-être qu'il va passer sans problème. Ou bien un petit pain, ou bien quelque chose de solide. Mais les choses sont inversées chez le malade qui a une dysphagie paradoxale.

Donc le symptôme oesophagien, il comprend la dysphagie, la difficulté à déglutir, le régime du patient, ça veut dire que les aliments n'arrivent pas jusqu'à l'estomac, ils stagnent au niveau de l'osophage. D'ailleurs quand on fait une radio standard, on peut observer un niveau hydraulique au niveau de l'osophage, au niveau du thorax. Alors que normalement, chez tout individu qui est normal, on ne voit pas ce niveau hydraulique.

Il ne doit pas y exister. Parce que tout simplement, la lumière de l'osophage au moment, elle est collabée. Elle n'existe pas.

Elle est virtuelle. Donc dysphagie, l'irrégularisation et l'hypersalivation du fait que la salive n'est pas récupérée dans ce cycle angéro-épilé. Alors, la dysphagie, il faut toujours préciser le début.

Est-ce qu'il est brutal ou progressif ? Intermittente ou pérenne ? Est-ce qu'il est d'abord au solide, puis au liquide, puis total ? Le cancer, quand on a un cancer, il ne s'installe pas d'un jour au lendemain, un cancer. Le cancer, il a besoin d'une histoire naturelle. Le malade qui a un cancer, tout d'abord il accumule des petites, de petits volumes, une petite gêne, il ne sent pas la dysphagie correctement.

Quand vous demandez au malade, il va vous dire que ça s'est installé pendant 14 jours, ou 15 jours, ou deux semaines. C'est ça l'installation progressive. Donc, l'installation, elle est

progressive.

Les signes associés, c'est surtout la remontée des aliments dans la bouche, l'hypertie à l'oreille, les brûles de rétropharynx mâle, et l'engouissement. Alors, les signes physiques d'accompagnement, rappelez-vous qu'on a dit que l'œsophage est un organe qui est profond, inaccessible à l'examen clinique. Donc, c'est un organe qui est profond.

On doit examiner l'état général, chercher des signes de déshydratation. Si le patient ne boit pas assez d'eau, il va être déshydraté. Chercher le pli de déshydratation, des signes de dénutrition.

L'examen cervical doit rechercher une masse latéro-cervicale qui peut expliquer la cause de cette dysphagie, notamment un diverticule œsophagien de Zenker. Des adénopathies sous-cervicales gauches. Et puis l'examen abdominal, chercher une masse.

Mais l'examen clé, c'est surtout, à demander, c'est surtout la fibroscopie digestive haute qui va voir la lésion, précise son siège. La tumeur peut siéger au niveau de l'œsophage cervical, elle peut être haute. On doit préciser si la tumeur siège au niveau de l'œsophage thoracique ou au niveau de l'œsophage abdominal.

Donc, vous voyez que le siège peut être différent et permet de faire des biopsies. Chaque fois qu'on trouve une lésion, il faut prendre une psychologue pour l'adresser au médecin, un homopathologiste pour nous dire et confirmer le diagnostic de tumeur. Les étiologies les plus fréquemment rencontrées, c'est surtout le cancer de l'œsophage, les sténoses peptiques, le reflux à la langue, il peut se compliquer d'une sténose peptique.

Et puis, on a les sténoses postiques. Quand quelqu'un prend de l'HCL dans un but suicidaire ou dans un but accidentellement, on peut faire, avec une complication, une sténose postique. Les compressions extrinsèques par des masses médiastinales, des tumeurs médiastinales et puis, les compressions par les diverticules œsophagiens.

La calasie, c'est le méga-œsophage, c'est la dysphagie paroxystique qu'on a vu tout à l'heure. Dysphagie paroxystique, c'est qu'elle est d'abord au liquide puis au solide. Dû à une hypertonie du système inférieur de l'œsophage, on peut avoir des troubles de l'œsophage.

Le reflux, c'est une pathologie qui est très fréquente et elle est sous-estimée dans notre contexte marocain. Souvent, il y a plusieurs raisons. Le patient peut être obèse, il peut avoir une maladie tranquillisante, des habitudes de l'hygiène de vie très mauvaise, il prend le grignotage activement le soir et il va toucher à minuit, il fait le plein, en quelque sorte, ça entraîne un reflux.

D'ailleurs, vous allez voir dans le traitement de cette pathologie qui est le reflux gastro-œsophagien, ce sont des conseils. Rien qu'avec les conseils hygiéno-diététiques, rien qu'en donnant au patient et en lui consacrant du temps, en lui expliquant, on peut régler ce problème et le traiter sans avoir recours à l'éthique ni à la chirurgie. Le traitement de cette pathologie, d'abord,

la base, ce sont les règles hygiéno-diététiques.

Si le patient, par exemple, vous allez parler avec votre patient, vous allez découvrir qu'il prend son dîner tard le soir, vous allez lui dire, écoutez monsieur, première règle, c'est que dès maintenant, vous allez prendre le dîner 19h. 19h ou 19h30, dernier repas. Comme ça, il aura le temps de digérer ce qu'il a mangé le soir, ne pas trop manger le soir.

Ça aussi, c'est une règle hygiéno-diététique à expliquer au patient. D'ailleurs, il y a des règles qui disent qu'il faut prendre son petit-déj comme un roi, déjeuner comme un prince et prendre le dîner comme quelqu'un de pauvre. C'est une règle très importante.

Donc le soir, pas de de bouffe très importante. On peut traiter ce refus gastro-oesophagien rien que par les règles hygiéno-diététiques. Et puis, l'oreiller, il ne faut pas avoir la tête plate, il faut garder un oreiller correct pour soulever la tête et empêcher le refus gastro-oesophagien.

Pour éviter l'antéflexion, certains habitudes alimentaires, le café le soir, l'alcool, le pyrosis, c'est la sensation de brûle rétrosternale due à la remontée du liquide dans l'oesophage. Et puis vous avez, comme signe parfois, les régurgitations et on peut avoir la dysphagie et le zémathémèse. Les six fonctionnaires de ce refus, ce sont les palesthésies, les dysphagies matinales, ce sont des symptômes qu'on note surtout chez les enfants.

Chez les enfants, on peut avoir des angines qui sont dues au refus gastro-oesophagien. D'ailleurs, les mamans savent ça très bien. Quand ils donnent la tété le soir ou tard la nuit, le malade, si le malade, on ne pratique pas chez lui la régurgitation, il peut présenter des dysphonies matinales.

On peut avoir des pneumopathies à répétition secondaire au refus et de la tourne nocturne. Le refus, les amas complémentaires à demander, c'est la fibroscopie digestive haute. On peut se céder par un transit oesophagien, une opacification et d'autres examens complémentaires pour confirmer cette pathologie, notamment la PH méris et la manométrie.

En conclusion, on va dire que l'analyse sémiologique d'être honnête, il a un rôle très important dans le diagnostic des raisons et des causes de cette dysphagie. Si vous avez un patient qui a une dysphagie, vous pouvez rien que par l'interrogatoire arriver au diagnostic. Par exemple, si le patient est d'un certain âge, 60 ans, s'il est alcoolique, tabac d'alcool, ce sont des facteurs favorisant du cancer de l'oesophage.

Vous pouvez, rien qu'en répondant des données à l'anamnèse, arriver à un diagnostic. Le diagnostic formel, c'est surtout la fibroscopie digestive.